APOSTILA EM FICHAS • TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Avaliação, técnica, coberturas, prevenção, registros e situações críticas no CTI, emergência e APH.

Setembro de 2026 • Material educativo • Referências oficiais ao final

Como usar esta apostila

O foco é desenvolver raciocínio seguro para observar a lesão, executar o cuidado prescrito, reconhecer alterações e comunicar o enfermeiro. O material não substitui avaliação, prescrição, capacitação prática ou protocolo institucional.

Ciclo do curativo

Confirmar → avaliar dor e segurança → retirar atraumaticamente → observar → limpar conforme protocolo → aplicar cobertura prescrita → fixar → reavaliar → registrar.

Competência do técnico

Pela Resolução Cofen nº 787/2025, o técnico realiza cuidados de prevenção, tratamento e reabilitação de lesões cutâneas conforme prescrição e supervisão do enfermeiro; registra características, procedimento e materiais; orienta sobre o procedimento; e comunica alterações imediatamente. A seleção e prescrição de coberturas cabem ao enfermeiro.

Objetivos

- Avaliar sistematicamente pele, ferida, dor, exsudato, bordas e perilesão.
- Reconhecer coberturas e compreender sua função sem prescrever.
- Executar o curativo com técnica segura e mínima agressão ao tecido.
- Prevenir lesão por pressão e lesões relacionadas a dispositivos.
- Atuar com segurança em hemorragias, queimaduras e trauma.
- Registrar achados, materiais, resposta e comunicação.

1. Pele, ferida e cicatrização

A ferida é resultado de uma causa; o curativo é apenas uma parte do tratamento.

Funções da pele

O QUE É / OBJETIVO

Barreira física, imunológica, sensorial e reguladora.

NA PRÁTICA

Inspecione cor, temperatura, umidade, integridade e perfusão no cuidado diário.

ATENÇÃO

Pele frágil pode lesar durante banho, transferência, adesivos e dispositivos.

Hemostasia e inflamação

O QUE É / OBJETIVO

O organismo controla o sangramento e inicia a limpeza celular.

NA PRÁTICA

Observe sangramento, edema, calor, dor e evolução. Inflamação inicial não significa automaticamente infecção.

ATENÇÃO

Sangramento persistente ou deterioração sistêmica exige escalonamento.

Proliferação

O QUE É / OBJETIVO

Forma-se tecido de granulação, vasos e epitélio.

NA PRÁTICA

Proteja tecido viável, controle trauma e mantenha o ambiente prescrito.

ATENÇÃO

Gaze seca aderida pode remover tecido novo.

Remodelamento

O QUE É / OBJETIVO

O colágeno amadurece e a resistência aumenta gradualmente.

NA PRÁTICA

Proteja a cicatriz e oriente contra trauma conforme plano.

ATENÇÃO

A cicatriz nunca recupera imediatamente a resistência da pele íntegra.

Fatores que atrasam

O QUE É / OBJETIVO

Hipoperfusão, hipóxia, pressão, edema, infecção, hiperglicemia, desnutrição, tabagismo e medicamentos podem interferir.

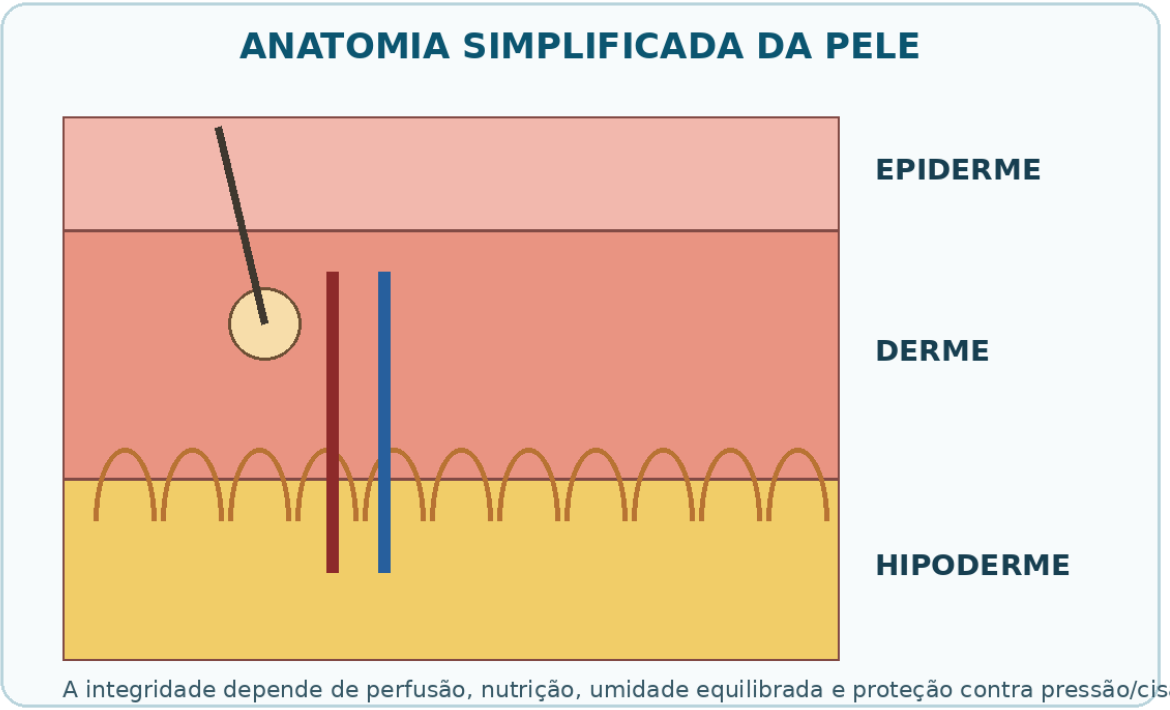
NA PRÁTICA

Observe o paciente inteiro: perfusão, mobilidade, nutrição, glicemia, dor e suporte hemodinâmico.

ATENÇÃO

Cobertura isolada não corrige a causa sistêmica.

Mapa visual • anatomia da pele



Esquema didático elaborado para esta apostila; não representa escala anatômica.

2. Avaliação sistemática da ferida

A descrição padronizada permite comparar a evolução e orientar decisões do enfermeiro.

Localização e provável causa

O QUE É / OBJETIVO

O local e o mecanismo ajudam a diferenciar pressão, trauma, umidade, cirurgia e doença vascular.

NA PRÁTICA

Use referência anatômica e lateralidade: calcâneo direito, região sacral, antebraço esquerdo.

ATENÇÃO

Não classifique toda lesão sacral como lesão por pressão.

Dimensões e profundidade

O QUE É / OBJETIVO

Comprimento, largura e profundidade permitem acompanhar a evolução.

NA PRÁTICA

Meça conforme protocolo, usando a mesma técnica; não explore trajetos cegamente.

ATENÇÃO

Túneis, descolamentos e estruturas expostas precisam do enfermeiro.

Leito

O QUE É / OBJETIVO

Granulação, epitelização, esfacelo, escara e estruturas visíveis orientam o objetivo do cuidado.

NA PRÁTICA

Descreva proporção aproximada conforme treinamento e protocolo.

ATENÇÃO

Cor isolada não define viabilidade ou infecção.

Exsudato e odor

O QUE É / OBJETIVO

Quantidade, aspecto e mudança ao longo do tempo mostram equilíbrio de umidade e possível deterioração.

NA PRÁTICA

Descreva seroso, sanguinolento, serossanguinolento ou purulento e pequena/moderada/grande quantidade.

ATENÇÃO

Odor deve ser reavaliado após limpeza; sozinho não confirma infecção.

Bordas e perilesão

O QUE É / OBJETIVO

Macerada, descolada, hiperqueratótica, eritematosa, edemaciada ou frágil.

NA PRÁTICA

Observe dermatite, adesivo, pressão e vazamento da cobertura.

ATENÇÃO

Eritema progressivo, calor, dor crescente ou bolhas hemorrágicas são alertas.

Dor

O QUE É / OBJETIVO

É achado clínico e também indicador de tolerância ao procedimento.

NA PRÁTICA

Avalie antes, durante e depois; use analgesia prescrita e técnica atraumática.

ATENÇÃO

Dor desproporcional pode indicar complicação grave.

Mapa visual • tecidos do leito

Reconhecimento visual educativo; a avaliação clínica considera o conjunto de achados.

3. Preparação e técnica geral do curativo

A técnica correta reduz contaminação, trauma, dor e falhas de cobertura.

Antes de começar

O QUE É / OBJETIVO

Confirmar paciente, prescrição, alergias, materiais, analgesia, posição e privacidade.

NA PRÁTICA

Explique o procedimento; organize tudo antes de expor a lesão; avalie necessidade de ajuda.

ATENÇÃO

Não inicie se houver dúvida sobre cobertura, local ou frequência.

Higiene das mãos e EPI

O QUE É / OBJETIVO

As precauções dependem do risco de contato, respingo e transmissão.

NA PRÁTICA

Higienize antes/depois; use luvas e demais EPI conforme técnica e protocolo.

ATENÇÃO

Luva não substitui higiene das mãos.

Retirada da cobertura

O QUE É / OBJETIVO

Deve minimizar trauma e permitir observar o material removido.

NA PRÁTICA

Solte adesivos no sentido do pelo/pele, sustente a pele e umedeça apenas se previsto.

ATENÇÃO

Sangramento, dor intensa ou aderência inesperada: pare e reavalie.

Limpeza

O QUE É / OBJETIVO

Remove resíduos sem lesar tecido viável.

NA PRÁTICA

Use solução, método, pressão e temperatura conforme protocolo; SF 0,9% é comum, mas não é regra universal.

ATENÇÃO

Não aplique antisséptico ou produto caseiro indiscriminadamente no leito.

Aplicação e fixação

O QUE É / OBJETIVO

A cobertura deve tocar o leito conforme indicação e permanecer sem compressão indevida.

NA PRÁTICA

Proteja perilesão quando prescrito, preencha cavidades suavemente e fixe sem tração.

ATENÇÃO

Não compacte cavidades nem faça voltas circulares apertadas.

Após o procedimento

O QUE É / OBJETIVO

Confirmar conforto, perfusão, sangramento, identificação e descarte.

NA PRÁTICA

Organize o paciente, higienize mãos, registre achados, materiais e resposta.

ATENÇÃO

Reavalie perfusão distal quando houver enfaixamento de membro.

4. Coberturas: função, indicação e limites

Conhecer a função evita improvisos. A escolha final depende do enfermeiro, da etiologia, perfusão, exsudato, profundidade, fabricante e protocolo.

Gaze estéril

O QUE É / OBJETIVO
Proteção, absorção e cobertura secundária.

NA PRÁTICA
Útil em diferentes montagens prescritas; observar saturação e aderência.

ATENÇÃO
Gaze seca diretamente sobre granulação pode traumatizar.

Não aderente

O QUE É / OBJETIVO
Reduz trauma na remoção.

NA PRÁTICA
Feridas superficiais, pele frágil, incisões e áreas dolorosas selecionadas.

ATENÇÃO
Tem absorção limitada e pode exigir cobertura secundária.

Filme transparente

O QUE É / OBJETIVO
Barreira semipermeável e visualização.

NA PRÁTICA
Proteção da pele e feridas muito superficiais com baixo exsudato.

ATENÇÃO
Não controla exsudato moderado/alto; risco de maceração.

Hidrocolóide

O QUE É / OBJETIVO
Forma gel e mantém ambiente úmido.

NA PRÁTICA
Feridas selecionadas com baixo/moderado exsudato.

ATENÇÃO
Cautela em infecção, isquemia e alto exsudato; o gel pode ter odor próprio.

Hidrogel

O QUE É / OBJETIVO
Doa umidade.

NA PRÁTICA
Feridas secas selecionadas e desbridamento autolítico prescrito.

ATENÇÃO
Pode macerar; geralmente requer cobertura secundária.

Espuma

O QUE É / OBJETIVO

Absorve e protege contra trauma.

NA PRÁTICA

Exsudato moderado e áreas vulneráveis; formatos para dispositivos.

ATENÇÃO

Pode ressecar leito seco; escolha depende da anatomia.

Alginato

O QUE É / OBJETIVO

Alta absorção e gelificação na presença de exsudato.

NA PRÁTICA

Feridas exsudativas e cavidades conforme prescrição.

ATENÇÃO

Não usar em leito seco; não compactar; atenção a sangramento.

Hidrofibra

O QUE É / OBJETIVO

Absorção vertical e formação de gel.

NA PRÁTICA

Exsudato moderado/alto e cavidades selecionadas.

ATENÇÃO

Depende de exsudato; requer margem e cobertura conforme fabricante.

Antimicrobianos

O QUE É / OBJETIVO

Produtos com prata ou outras tecnologias para biocarga/infecção selecionada.

NA PRÁTICA

Usar por indicação, tempo definido e reavaliação.

ATENÇÃO

Não manter indefinidamente nem combinar sem avaliar compatibilidade.

Barreira cutânea

O QUE É / OBJETIVO

Protege contra umidade, efluentes e adesivos.

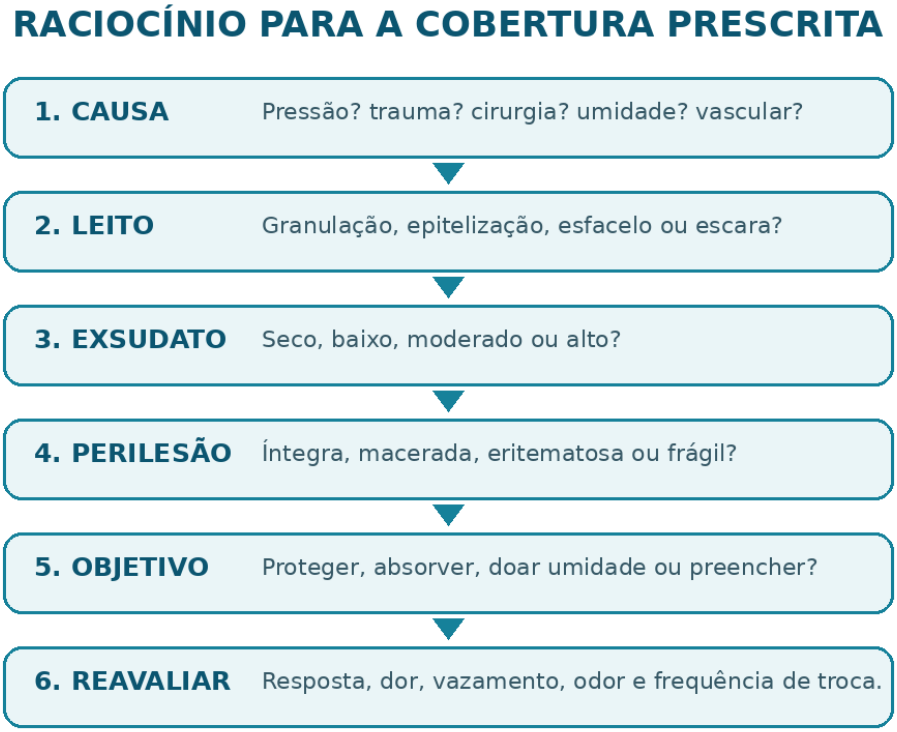
NA PRÁTICA

Perilesão, incontinência, estomas e pele frágil conforme produto.

ATENÇÃO

Não substitui controle da causa e higiene adequada.

Mapa visual • decisão sobre coberturas



O técnico executa o plano prescrito; seleção e prescrição da cobertura cabem ao enfermeiro.

O fluxograma organiza o raciocínio, mas não substitui a prescrição do enfermeiro.

Mapa mental • curativos e coberturas na UTI

Fonte visual: 350 mapas mentais UTI atualizado, página 345 do PDF enviado pelo usuário.

Leitura crítica: Use o mapa para revisão. A indicação e a prescrição das coberturas cabem ao enfermeiro; o técnico executa o cuidado prescrito, observa a resposta e comunica alterações.

5. Desbridamento e controle de biocarga

Desbridar não significa simplesmente retirar qualquer tecido escuro ou amarelo.

Autolítico

O QUE É / OBJETIVO
Utiliza enzimas do organismo em ambiente úmido.

NA PRÁTICA
O técnico mantém a cobertura prescrita e observa evolução, vazamento e maceração.

ATENÇÃO
É mais lento e depende de perfusão e seleção adequada.

Enzimático

O QUE É / OBJETIVO
Agente tópico prescrito atua sobre tecido desvitalizado.

NA PRÁTICA
Aplique exatamente conforme prescrição e fabricante, protegendo a perilesão.

ATENÇÃO
Compatibilidade com outros produtos pode ser crítica.

Mecânico

O QUE É / OBJETIVO
Remoção física; pode ser pouco seletiva e dolorosa.

NA PRÁTICA
Somente conforme técnica institucional e competência.

ATENÇÃO
“Gaze seca para arrancar” pode lesar tecido viável.

Instrumental conservador/cirúrgico

O QUE É / OBJETIVO
Remove tecido com instrumental e tem risco de sangramento.

NA PRÁTICA
Cabe ao enfermeiro capacitado ou equipe habilitada conforme técnica e complexidade.

ATENÇÃO
Conhecimento teórico não autoriza o técnico a executar desbridamento instrumental.

Escara seca estável

O QUE É / OBJETIVO
Pode funcionar como cobertura biológica em situações selecionadas.

NA PRÁTICA
Mantenha protegida e comunique alterações conforme plano.

ATENÇÃO
Não remova escara seca estável de calcâneo/membro isquêmico sem avaliação de perfusão e prescrição.

Infecção e biofilme

O QUE É / OBJETIVO

Infecção resulta da interação entre microrganismos, tecido e hospedeiro.

NA PRÁTICA

Observe dor crescente, eritema em expansão, calor, edema, exsudato purulento, tecido friável, odor persistente e sinais sistêmicos.

ATENÇÃO

Cultura e diagnóstico não se baseiam apenas na aparência; comunique o enfermeiro.

6. Lesão por pressão e prevenção

No CTI, sedação, imobilidade, edema, vasopressores e dispositivos elevam muito o risco.

Avaliação de risco e pele

O QUE É / OBJETIVO

Deve ocorrer na admissão e periodicamente conforme protocolo.

NA PRÁTICA

Inspecione proeminências, dispositivos, dobras, umidade e perfusão; comunique mudanças precoces.

ATENÇÃO

Escala de risco não substitui inspeção clínica.

Reposicionamento

O QUE É / OBJETIVO

Redistribui pressão e reduz tempo de exposição.

NA PRÁTICA

Siga plano individualizado, tolerância hemodinâmica e superfície de apoio; use equipe e dispositivos de transferência.

ATENÇÃO

Não existe frequência única segura para todos.

Calcâneos

O QUE É / OBJETIVO

São áreas de alto risco e podem desenvolver lesão profunda.

NA PRÁTICA

Descarregue totalmente quando prescrito, mantendo panturrilha apoiada e calcâneo livre.

ATENÇÃO

Não use dispositivos improvisados que concentrem pressão.

Umidade e incontinência

O QUE É / OBJETIVO

Maceram a pele e aumentam fricção.

NA PRÁTICA

Higiene suave, secagem sem atrito, barreira prescrita e plano de continência.

ATENÇÃO

Dermatite associada à incontinência não é automaticamente LPP.

Dispositivos médicos

O QUE É / OBJETIVO

TOT, máscara, sonda, colar, cateter, sensor e fixação podem causar pressão.

NA PRÁTICA

Inspecione sob/ao redor do dispositivo, reposicione quando permitido e use proteção prescrita.

ATENÇÃO

Não comprometa a função do dispositivo para aliviar pressão.

Prona

O QUE É / OBJETIVO

Cria pontos de pressão em face, tórax, cristas ilíacas, joelhos e genitais.

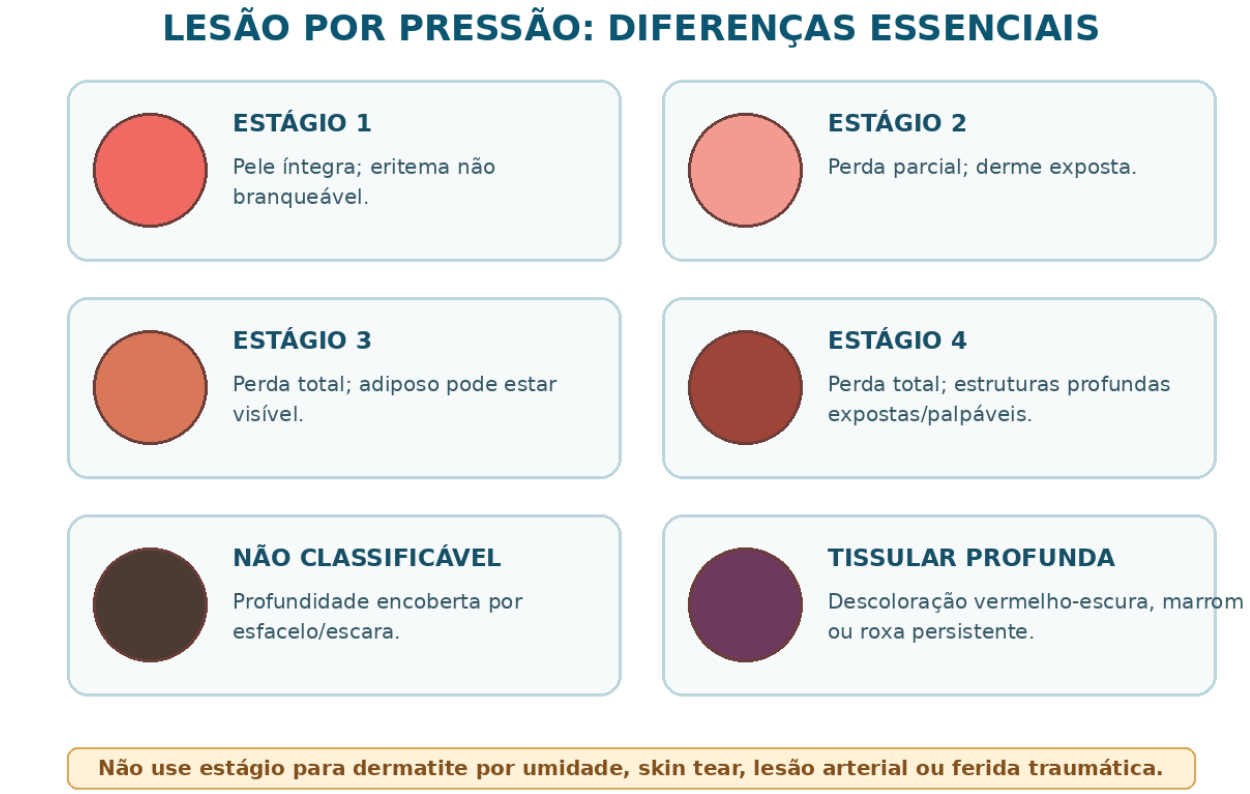
NA PRÁTICA

Use checklist antes/durante/depois; alinhe dispositivos e inspeções possíveis.

ATENÇÃO

Instabilidade e via aérea têm prioridade durante qualquer reposicionamento.

Mapa visual • lesão por pressão



Classificação didática baseada na descrição adotada em protocolos de segurança; confirmar pelo enfermeiro.

Mapa mental • prevenção de lesão por pressão na UTI

Fonte visual: 350 mapas mentais UTI atualizado, página 64 do PDF enviado pelo usuário.

Leitura crítica: A prevenção é individualizada. O reposicionamento deve considerar tolerância clínica, perfusão, dispositivos e o protocolo institucional.

7. Feridas e dispositivos no CTI

O curativo deve preservar a terapia e permitir vigilância do paciente crítico.

Ferida operatória

O QUE É / OBJETIVO

Observar bordas, aproximação, exsudato, dor, calor, edema e deiscência.

NA PRÁTICA

Manuseie conforme técnica e frequência prescritas; apoie a incisão durante mobilização quando orientado.

ATENÇÃO

Abertura súbita, evisceração, sangramento ou secreção purulenta requer ação imediata.

Traqueostomia

O QUE É / OBJETIVO

Secreção, umidade, pressão da flange e fixação elevam risco.

NA PRÁTICA

Faça higiene e curativo conforme protocolo; mantenha fixação segura e observe pele periestoma.

ATENÇÃO

Nunca use material cortado que libere fibras junto ao estoma se o protocolo proibir.

Drenos

O QUE É / OBJETIVO

Risco de tração, vazamento, infecção e lesão por pressão.

NA PRÁTICA

Observe inserção, fixação, débito, aspecto e pele; mantenha sistema posicionado.

ATENÇÃO

Mudança abrupta de débito, perda de vácuo ou exteriorização exige comunicação.

Cateteres vasculares

O QUE É / OBJETIVO

Curativo protege inserção e permite vigilância.

NA PRÁTICA

Use técnica e antisséptico do protocolo, respeite secagem, integridade e prazo de troca.

ATENÇÃO

Não encubra secreção, sangramento ativo ou sinais de complicação sem avaliação.

Estomas e incontinência

O QUE É / OBJETIVO

Efluentes podem causar dermatite e falha de adesão.

NA PRÁTICA

Limpe suavemente, meça quando indicado e proteja pele periestoma conforme sistema.

ATENÇÃO

Pele periestoma persistentemente úmida exige revisar adaptação e causa.

Terapia por pressão negativa

O QUE É / OBJETIVO

Controla exsudato e promove condições locais em feridas selecionadas.

NA PRÁTICA

O técnico treinado monitora selo, alarme, reservatório, pele e sistema conforme prescrição.

ATENÇÃO

Sangramento, dor súbita, perda persistente de selo ou instabilidade exigem interrupção/escalonamento conforme protocolo.

8. Emergência: feridas traumáticas

Na emergência, primeiro vêm ABCDE, controle de hemorragia e avaliação neurovascular.

Abrasão e laceração

O QUE É / OBJETIVO

Perda superficial ou ruptura irregular da pele.

NA PRÁTICA

Controle sangramento, proteja, avalie contaminação, mecanismo, dor, sensibilidade e movimento.

ATENÇÃO

Não explore profundamente nem remova corpo estranho incrustado.

Perfuração e empalamento

O QUE É / OBJETIVO

O orifício externo pode ocultar trajeto profundo.

NA PRÁTICA

Estabilize o objeto, comprima ao redor, monitore perfusão e prepare transporte/avaliação.

ATENÇÃO

Nunca retire objeto empalado fora de ambiente/controlado indicado.

Avulsão e amputação

O QUE É / OBJETIVO

Perda/descolamento de tecido com risco hemorrágico e isquêmico.

NA PRÁTICA

Controle hemorragia; preserve segmento conforme protocolo, protegido e refrigerado indiretamente.

ATENÇÃO

Não coloque tecido diretamente no gelo ou água.

Esmagamento

O QUE É / OBJETIVO

Dano profundo pode exceder a aparência da pele.

NA PRÁTICA

Avalie perfusão, dor, edema, função e trauma associado; monitorize deterioração.

ATENÇÃO

Dor crescente, parestesia, palidez ou pulso alterado são alertas.

Evisceração

O QUE É / OBJETIVO

Exteriorização de vísceras por ferida abdominal.

NA PRÁTICA

Proteja com cobertura estéril umedecida conforme protocolo, evite pressão direta e acione equipe cirúrgica.

ATENÇÃO

Não reintroduza vísceras nem ofereça alimento/líquido.

Mordeduras

O QUE É / OBJETIVO

Risco de infecção, lesão profunda e profilaxias específicas.

NA PRÁTICA

Irrigue conforme protocolo, identifique agente quando possível e avalie tétano/raiva pela equipe.

ATENÇÃO

Não feche ou trate como ferida simples sem avaliação.

9. APH: controle de hemorragias e proteção

No APH, o objetivo é controlar ameaça à vida, proteger a lesão e transportar com segurança.

Compressão direta

O QUE É / OBJETIVO

Primeira medida para muitas hemorragias externas.

NA PRÁTICA

Aplique gaze/tecido limpo e pressão firme contínua; fixe curativo compressivo quando controlado.

ATENÇÃO

Evite retirar repetidamente para “olhar”.

Curativo saturado

O QUE É / OBJETIVO

Remover a primeira camada pode desfazer o coágulo.

NA PRÁTICA

Reforce por cima e mantenha compressão; reavalie estado geral e perfusão distal.

ATENÇÃO

Sangramento maciço exige protocolo específico e transporte prioritário.

Torniquete

O QUE É / OBJETIVO

Recurso para hemorragia grave de extremidade quando indicado pelo protocolo.

NA PRÁTICA

Aplicar somente com treinamento, material adequado, local e horário registrados; não afrouxar rotineiramente.

ATENÇÃO

Uso inadequado causa dano; siga protocolo do serviço.

Ferida de tórax

O QUE É / OBJETIVO

Pode comprometer ventilação e evoluir rapidamente.

NA PRÁTICA

Priorize ABC, cobertura específica somente conforme protocolo e monitore piora respiratória.

ATENÇÃO

Curativo inadequado pode agravar pneumotórax; não improvise sem treinamento.

Objeto encravado

O QUE É / OBJETIVO

A retirada pode desencadear hemorragia.

NA PRÁTICA

Estabilize com volume ao redor sem pressionar o objeto e monitore perfusão/respiração.

ATENÇÃO

Não encurte nem remova, salvo risco excepcional previsto em protocolo.

Transporte

O QUE É / OBJETIVO

A cobertura precisa permanecer segura sem esconder deterioração.

NA PRÁTICA

Registre mecanismo, tempo, sangramento, medidas, perfusão e resposta; repasse de forma estruturada.

ATENÇÃO

Não atrase transporte de paciente instável por curativo definitivo.

10. Queimaduras

A gravidade depende do mecanismo, profundidade, extensão, localização, idade, comorbidades e lesão inalatória.

Primeira abordagem

O QUE É / OBJETIVO

Interromper o agente com segurança e priorizar ABCDE.

NA PRÁTICA

Remova adornos e roupas não aderidas; proteja da hipotermia e avalie mecanismo.

ATENÇÃO

Face, pescoço, fumaça, rouquidão, fuligem e queimadura circunferencial são alertas.

Térmica

O QUE É / OBJETIVO

Calor causa lesão progressiva enquanto a fonte permanece.

NA PRÁTICA

Resfrie com água corrente conforme protocolo e tempo do evento; cubra com material limpo/não aderente.

ATENÇÃO

Não use gelo, pasta de dente, café, manteiga ou pomada aleatória.

Química

O QUE É / OBJETIVO

Agentes exigem descontaminação compatível.

NA PRÁTICA

Proteja a equipe; remova roupa contaminada e pó seco antes da irrigação quando aplicável; identifique o produto.

ATENÇÃO

Alguns agentes têm condutas específicas: acione referência toxicológica/protocolo.

Elétrica

O QUE É / OBJETIVO

A lesão externa pode ser pequena, com dano profundo e arritmia.

NA PRÁTICA

Desenergize a cena antes de tocar, monitore e procure pontos de entrada/saída.

ATENÇÃO

Nunca subestime pela aparência da pele.

Profundidade

O QUE É / OBJETIVO

Pode ser superficial, espessura parcial ou total.

NA PRÁTICA

Descreva cor, umidade, bolhas, dor e perfusão sem romper bolhas por conta própria.

ATENÇÃO

A profundidade pode evoluir; reavaliação é necessária.

Extensão e áreas especiais

O QUE É / OBJETIVO

Mãos, face, pés, genitais, períneo e grandes articulações têm alto impacto funcional.

NA PRÁTICA

Use método institucional para extensão e encaminhamento; mantenha temperatura corporal.

ATENÇÃO

Não aplique fórmula de reposição volêmica sem prescrição e dados corretos.

11. Registros e comunicação

O prontuário deve permitir comparar a evolução e saber exatamente o que foi feito.

Antes do curativo

O QUE É / OBJETIVO

Dor, condição da cobertura anterior e motivo da troca.

NA PRÁTICA

Registre vazamento, saturação, odor, deslocamento e queixas.

ATENÇÃO

Evite apenas “curativo sujo”.

Características

O QUE É / OBJETIVO

Local, dimensões quando atribuídas, leito, exsudato, bordas, perilesão, dor e sinais de alerta.

NA PRÁTICA

Use termos objetivos e valores; fotografe somente com autorização e sistema institucional.

ATENÇÃO

Não use imagem pessoal ou aplicativo não autorizado.

Procedimento e materiais

O QUE É / OBJETIVO

Solução, técnica relevante, cobertura primária/secundária, fixação e quantidade.

NA PRÁTICA

Registre o que foi realmente usado e intercorrências.

ATENÇÃO

Não escreva “curativo realizado” como único dado.

Resposta

O QUE É / OBJETIVO

Dor após, sangramento, perfusão, tolerância e condição final.

NA PRÁTICA

Inclua quem foi comunicado, horário e conduta recebida.

ATENÇÃO

Registro não substitui comunicação imediata.

Exemplo completo

O QUE É / OBJETIVO

Estrutura: horário + achados + procedimento + cobertura + resposta + comunicação + identificação.

NA PRÁTICA

“10:20 - Curativo sacral conforme prescrição. Cobertura anterior com moderado exsudato seroso. Leito com granulação predominante; bordas aderidas; perilesão sem maceração. Limpeza e cobertura prescrita aplicadas. Dor 2/10 após. Sem sangramento. Enfermeira ciente.”

ATENÇÃO

Adapte ao que foi observado; nunca copie automaticamente.

12. Consulta rápida de coberturas

Tabela didática: não é prescrição. Sempre confira prescrição, fabricante, compatibilidade e protocolo.

Cobertura	Função	Exsudato típico	Cuidado principal
Gaze	Proteção/absorção	Variável	Aderência e saturação
Não aderente	Reduz trauma	Baixo	Precisa de secundária
Filme	Barreira/visualização	Muito baixo	Macerar em exsudato
Hidrocolóide	Gel/ambiente úmido	Baixo a moderado	Infecção/alto exsudato
Hidrogel	Doa umidade	Leito seco	Macerar perilesão
Espuma	Absorve/protege	Moderado	Leito seco
Alginato	Alta absorção	Moderado a alto	Não usar seco/compactar
Hidrofibra	Absorção vertical/gel	Moderado a alto	Depende de exsudato
Prata/antimicrobiano	Controle selecionado de biocarga	Conforme produto	Uso indefinido/compatibilidade
Barreira	Protege pele	Não se aplica	Não corrige causa

Regra de ouro

A cobertura é escolhida pelo objetivo terapêutico, não apenas pelo nome da ferida. A mesma ferida pode exigir produtos diferentes conforme fase, exsudato, perfusão e resposta.

13. Diferenciais importantes

Condição	Mecanismo	Pistas	Prioridade
LPP	Pressão/cisalhamento; geralmente sobre proeminência ou dispositivo	Eritema não branqueável, perda tecidual, descoloração profunda	Aliviar pressão + avaliar/classificar
Dermatite associada à incontinência	Contato com urina/fezes	Difusa, superficial, bordas irregulares, áreas de contato	Controle de umidade + barreira
Skin tear	Fricção/cisalhamento em pele frágil	Retalho cutâneo parcial/total	Reposicionar retalho quando indicado + atraumático
MARSI	Adesivo médico	Eritema/ruptura persistente após remoção	Técnica de adesivo + barreira
Lesão arterial	Perfusão inadequada	Distal, dolorosa, seca/necrose, extremidade fria	Avaliação vascular; evitar desbridar/comprimir sem indicação
Lesão venosa	Hipertensão venosa	Região gaiter, edema, exsudato	Compressão somente após avaliação/prescrição
Neuropática	Perda de sensibilidade + pressão	Pontos plantares, calosidade	Descarga de pressão + avaliação metabólica

14. Casos clínicos comentados

CTI • noradrenalina e eritema sacral

O QUE É / OBJETIVO

Paciente sedado, edemaciado, extremidades frias e eritema sacral não branqueável.

NA PRÁTICA

Priorizar perfusão e alívio de pressão, revisar superfícies/dispositivos, comunicar e registrar. Cobertura isolada não resolve hipoperfusão e pressão.

ATENÇÃO

O caso serve para raciocínio; condutas específicas dependem do protocolo e da avaliação da equipe.

CTI • traqueostomia

O QUE É / OBJETIVO

Secreção abundante, maceração sob flange e marca de pressão lateral.

NA PRÁTICA

Avaliar fixação, higiene, umidade, proteção prescrita e necessidade de revisão do dispositivo; comunicar precocemente.

ATENÇÃO

O caso serve para raciocínio; condutas específicas dependem do protocolo e da avaliação da equipe.

Emergência • laceração por vidro

O QUE É / OBJETIVO

Sangramento contínuo em antebraço e redução de movimento dos dedos.

NA PRÁTICA

Hemostasia, avaliação neurovascular e suspeita de lesão profunda; não explorar a ferida nem assumir que é apenas cutânea.

ATENÇÃO

O caso serve para raciocínio; condutas específicas dependem do protocolo e da avaliação da equipe.

APH • objeto transfixante

O QUE É / OBJETIVO

Objeto metálico atravessa a panturrilha, com sangramento ao redor.

NA PRÁTICA

Não retirar; estabilizar, comprimir ao redor, reavaliar perfusão distal, controlar choque e transportar.

ATENÇÃO

O caso serve para raciocínio; condutas específicas dependem do protocolo e da avaliação da equipe.

Queimadura • líquido quente

O QUE É / OBJETIVO

Tórax e braço com áreas bolhosas; paciente tremendo.

NA PRÁTICA

Interromper agente, ABCDE, resfriamento conforme protocolo, retirar adornos, prevenir hipotermia, proteger e encaminhar.

ATENÇÃO

O caso serve para raciocínio; condutas específicas dependem do protocolo e da avaliação da equipe.

Ferida • piora inesperada

O QUE É / OBJETIVO

Dor intensa desproporcional, edema crescente, bolhas hemorrágicas e taquicardia.

NA PRÁTICA

Sinal de possível infecção profunda/complicação grave: interromper cuidado não essencial, acionar equipe imediatamente e monitorizar.

ATENÇÃO

O caso serve para raciocínio; condutas específicas dependem do protocolo e da avaliação da equipe.

15. Checklist de bolso

☐ Paciente, prescrição, alergias, local e cobertura confirmados.

☐ Dor avaliada e analgesia prescrita considerada.

☐ Materiais completos, integridade e validade conferidas.

☐ Higiene das mãos e EPI conforme risco.

☐ Cobertura anterior retirada atraumaticamente e observada.

☐ Leito, exsudato, odor, bordas e perilesão avaliados.

☐ Sinais de alerta comunicados antes de prosseguir.

☐ Limpeza e cobertura realizadas exatamente conforme plano.

☐ Fixação sem tração ou comprometimento da perfusão.

☐ Paciente confortável; sangramento e perfusão reavaliados.

☐ Material descartado e ambiente organizado.

☐ Registro completo com materiais, resposta e comunicação.

Pare e chame o enfermeiro

Sangramento persistente; dor desproporcional; necrose rápida; crepitação; bolha hemorrágica; eritema em expansão; exposição de estrutura; deiscência/evisceração; mudança abrupta de dreno; perfusão distal alterada; cobertura prescrita incompatível ou indisponível.

Erros que não podem virar rotina

• Escolher cobertura por conta própria.

• Usar antisséptico indiscriminadamente no leito.

• Compactar material em cavidade.

• Massagear eritema não branqueável.

• Desbridar sem competência, avaliação e prescrição.

• Fixar enfaixamento apertado sem checar perfusão.

• Retirar objeto empalado.

• Aplicar gelo diretamente ou receitas caseiras em queimadura.

• Fotografar lesão em aparelho pessoal.

• Registrar apenas “curativo realizado”.

16. Exercícios de fixação

1. Cobertura saturada

O que deve ser descrito antes de retirar? Quais riscos precisam ser comunicados?

2. Ferida seca com escara no calcâneo

Por que não se deve remover automaticamente?

3. Pele sacral úmida e difusamente avermelhada

Quais dados ajudam a diferenciar dermatite de LPP?

4. Curativo compressivo no APH

Como agir se a primeira camada saturar? O que reavaliar no membro?

5. Registro

Reescreva “feito curativo, sem alterações” de forma objetiva e completa.

6. Limite profissional

Quem avalia e prescreve a cobertura? O que cabe ao técnico?

Gabarito orientador

1. Quantidade/aspecto do exsudato, odor, vazamento, dor e sangramento; comunicar deterioração, secreção purulenta ou sangramento ativo.

2. A conduta depende de perfusão, estabilidade e etiologia; escara seca estável pode não ser removida.

3. Relação com pressão, formato, profundidade, distribuição, umidade, incontinência, branqueamento e bordas.

4. Reforçar por cima sem retirar a primeira; manter pressão e reavaliar sangramento, pulso, cor, temperatura, sensibilidade e enchimento capilar.

5. Incluir local, cobertura anterior, leito, exsudato, bordas/perilesão, limpeza, cobertura aplicada, dor/resposta e comunicação.

6. O enfermeiro realiza avaliação integral e prescreve cobertura; o técnico executa o cuidado prescrito, observa, registra e comunica alterações.

Referências e materiais utilizados

Consultadas em 23/09/2026. A prática deve seguir a versão vigente do protocolo institucional, a prescrição e a supervisão do enfermeiro.

Material anterior do usuário: Apostila Curativos CTI, Emergência e APH 2026. Conteúdo revisado, ampliado e rediagramado no padrão atual da coleção.

Mapas mentais fornecidos pelo usuário: 350 mapas mentais UTI atualizado, páginas 64 e 345. Inseridos proporcionalmente e acompanhados de leitura crítica.

COFEN. Resolução nº 787/2025 - atuação da equipe de enfermagem nas lesões cutâneas.
https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-787-de-21-de-agosto-de-2025/

ANVISA. Nota Técnica GVIMS/GGTES nº 05/2023 - prevenção de lesão por pressão.
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-gvims-ggtes-anvisa-no-05-2023-praticas-de-seguranca-do-paciente-em-servicos-de-saude-prevencao-de-lesao-por-pressao

Ministério da Saúde. Protocolos de Suporte Básico de Vida - SAMU 192.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf

COFEN. Protocolo de cuidados de enfermagem às vítimas de queimaduras.
https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/protocolo-cuidados-enfermagem-vitimas-queimadura.pdf

BRASIL. Lei nº 7.498/1986 - exercício profissional da Enfermagem.
https://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986/

BRASIL. Decreto nº 94.406/1987 - regulamentação da Lei nº 7.498/1986.
https://www.cofen.gov.br/decreto-n-9440687/

ANVISA. Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde.
https://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/1772

Aviso educativo

Imagens e esquemas são didáticos. Não substituem avaliação presencial, classificação pelo enfermeiro, indicação do fabricante, prescrição ou protocolo institucional.